



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Assistência por Sistemas

Cardiovascular · Respiratório · Nervoso · Urinário · Digestório ·
Músculo-esquelético · Endócrino
Concurso de Enfermagem / Pernambuco · Cargo: Enfermeiro

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

Diretrizes conferidas · SBC, SBD, Ministério da Saúde

O eixo mais clínico da prova

Aqui a banca deixa de perguntar "o que é" e passa a perguntar "o que você faz". São casos clínicos: um paciente chega, você reconhece e age.

Este ebook cobre os sete sistemas do conteúdo programático. Em cada um, você encontra a fisiopatologia que explica o cuidado, os números que a prova cobra e o modo como a banca monta o enunciado. Os dados foram conferidos nas diretrizes brasileiras vigentes.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Cardiovascular** — HAS, IAM, insuficiência cardíaca.
- ◆ **Respiratório** — DPOC, asma, insuficiência respiratória.
- ◆ **Nervoso** — AVC, escala de Glasgow, PIC.
- ◆ **Urinário, digestório, músculo-esquelético e endócrino.**

Nota de atualização

Diretrizes clínicas são revisadas periodicamente. Os parâmetros aqui seguem as versões vigentes (SBC, SBD, Ministério da Saúde). **Confirme a diretriz do ano antes da prova** — em clínica, o número exato é a questão.

Sumário

1 Sistema cardiovascular

Hipertensão arterial

Infarto agudo do miocárdio

Insuficiência cardíaca

2 Sistema respiratório

DPOC

Asma

Insuficiência respiratória

3 Sistema nervoso

AVC

Escala de Glasgow

Hipertensão intracraniana

4 Sistema urinário

Doença renal crônica

Diálise

Infecção urinária

5 Sistema digestório

Hemorragia digestiva

Cirroze

Pancreatite

6 Sistema músculo-esquelético

Fraturas

Imobilidade

Cuidados ortopédicos

7 Sistema endócrino

Diabetes mellitus

Emergências glicêmicas

Tireoide

8 Síntese e bizus finais

Revisão rápida

1

Sistema cardiovascular

Primeira causa de morte no Brasil — e um dos campeões de questão em qualquer prova.

1 · Hipertensão arterial

A hipertensão arterial (HA) é doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos sustentadamente elevados. É frequentemente **assintomática** — o que explica a baixa adesão e faz dela um problema de saúde pública.

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial — 2025 · SBC/SBH/SBN

◆ Classificação pela medida de consultório (adultos)

CLASSIFICAÇÃO	VALORES (CONSULTÓRIO, ≥ 18 ANOS)
PA normal	PAS < 120 e PAD < 80 mmHg.
Pré-hipertensão	PAS 120–139 e/ou PAD 80–89 mmHg.
HA estágio 1	PAS 140–159 e/ou PAD 90–99 mmHg.
HA estágio 2	PAS 160–179 e/ou PAD 100–109 mmHg.
HA estágio 3	PAS ≥ 180 e/ou PAD ≥ 110 mmHg.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A mudança de 2025 — a mais cobrada agora. O famoso “12 por 8” **deixou de ser normal**: 120/80 mmHg hoje é **pré-hipertensão**. A categoria PA ótima foi **extinta** e incorporada à PA normal, que agora é apenas < 120/80.

Como era antes (2020) × como é agora (2025):

- PA ótima < 120/80 e PA normal 120–129/80–84 → hoje: **PA normal** é só < 120/80.
- Pré-hipertensão 130–139/85–89 → hoje: **pré-hipertensão 120–139/80–89**.

O racional: pessoas na faixa 120–139/80–89 já têm risco cardiovascular aumentado. Antecipar o rótulo antecipa a intervenção. Os estágios 1, 2 e 3 **não mudaram**.

PEGADINHA CLÁSSICA

Não confunda três números diferentes, e a banca vive misturando:

- **120/80** — a partir daqui já é *pré-hipertensão* (e já se indicam mudanças de estilo de vida).
- **140/90** — o *diagnóstico* de hipertensão. Esse **não mudou** em 2025.
- **< 130/80** — a *meta terapêutica* universal do hipertenso tratado.

Ou seja: 120/80 rotula, 140/90 diagnostica, 130/80 é o alvo. Alternativa dizendo que “a diretriz de 2025 passou a diagnosticar hipertensão a partir de 130/80” está **errada** — isso é a diretriz americana.

◆ Metas e início do tratamento (2025)

O QUE MUDOU NO MANEJO

- ◆ **Meta universal: < 130/80 mmHg** para todos os hipertensos, sempre que tolerado — inclusive idosos, salvo exceções clínicas.
- ◆ A meta vale também para o acompanhamento por **MAPA e MRPA**.
- ◆ **Estágio 1 de baixo risco:** hoje inicia medicação **de imediato** (antes, esperava-se 3 meses de medidas não medicamentosas).
- ◆ **Pré-hipertenso de baixo risco:** sem medicação — só mudança de estilo de vida.
- ◆ **130–139/80–89 com alto risco:** considerar medicação se não houver resposta após 3 meses de MEV.

◆ Medida fora do consultório

Na monitorização residencial (MRPA), o valor anormal é mais baixo: $\geq 130/80$ mmHg. A diretriz de 2025 recomenda o **esfigmomanômetro automático de braço validado** e a confirmação diagnóstica por **MAPA ou MRPA** sempre que possível.

SITUAÇÃO	DEFINIÇÃO
Hipertensão do avental branco	PA elevada no consultório, normal fora dele.
Hipertensão mascarada	PA normal no consultório, elevada fora dele.
HA sistólica isolada	PAS ≥ 140 com PAD normal. Comum no idoso (rigidez arterial).

BIZU ESTRATÉGICO

Cuidados de enfermagem na aferição — cai direto: paciente **sentado, em repouso por 5 minutos**, pernas descruzadas, braço na altura do coração, manguito de tamanho adequado. Sem café, exercício ou fumo nos 30 minutos anteriores. Bexiga vazia. **Manguito estreito demais superestima a PA** — erro clássico no paciente obeso.

COMO A BANCA COBRA

“Homem de 45 anos, assintomático, apresenta PA de 124/82 mmHg. Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, esse valor classifica-se como...”

Pré-hipertensão (120–139/80–89). Pela diretriz de 2020 seria “PA normal” — por isso o enunciado cita o ano da diretriz. Sempre que a questão nomear a diretriz, ela está testando exatamente a mudança.

“...em duas consultas distintas, PA de 148/94 mmHg.”

HA estágio 1 — valor (140–159/90–99) + repetição em duas visitas, que valida o diagnóstico. Os estágios não mudaram em 2025.

1 · Infarto agudo do miocárdio

O IAM resulta da oclusão de artéria coronária, com necrose do miocárdio. A assistência de enfermagem gira em torno de uma palavra: **tempo**.

MANIFESTAÇÃO	CARACTERÍSTICA
Dor típica	Retroesternal, em aperto/opressão, irradiando para braço esquerdo, mandíbula ou dorso; dura mais de 20 minutos e não alivia com repouso.
Sintomas associados	Sudorese fria, náusea, dispneia, sensação de morte iminente.
Apresentação atípica	Mulheres, idosos e diabéticos podem ter dor ausente ou apenas dispneia, epigastria e mal-estar.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o **diabético** pode infartar sem dor: a neuropatia autonômica compromete as fibras que conduzem a dor visceral. É o chamado **infarto silencioso** — e é justamente por isso que ele chega tarde ao hospital e tem pior prognóstico. Diante de um diabético com dispneia súbita e sudorese, pense em IAM mesmo sem dor torácica.

BIZU ESTRATÉGICO

Conduta imediata da enfermagem na suspeita de IAM: **ECG de 12 derivações em até 10 minutos** da chegada. Depois: repouso, monitorização, acesso venoso, oxigênio se hipoxemia, e coleta de marcadores. O ECG precoce é a ação que mais cai.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas trocas frequentes: (1) **oxigênio para todos** — não; O₂ suplementar só se SatO₂ baixa, porque hiperóxia pode ser deletéria. (2) O marcador de escolha é a **troponina** (alta sensibilidade e especificidade), não a CK-MB, que é mais antiga e menos específica.

1 • Insuficiência cardíaca

Síndrome em que o coração não bombeia sangue suficiente para a demanda tecidual. Reconhecer **qual lado falhou** resolve a maioria das questões.

LADO ACOMETIDO	SINAIS E SINTOMAS
IC esquerda	Congestão pulmonar: dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, estertores, tosse, expectoração rosada.
IC direita	Congestão sistêmica: edema de membros inferiores, turgência jugular, hepatomegalia, ascite, ganho de peso.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica é hidráulica: se o **ventrículo esquerdo** falha, o sangue represa *para trás* — nos pulmões (edema pulmonar). Se o **direito** falha, represa na circulação sistêmica — nas pernas, no fígado, nas jugulares. Sabendo isso, você deduz os sinais sem decorar lista.

BIZU ESTRATÉGICO

Cuidados que caem: **pesar o paciente diariamente**, no mesmo horário e balança (ganho rápido = retenção hídrica antes do edema visível), controle rigoroso de hídrico, restrição de sódio, e posição de **Fowler** para aliviar a dispneia.

2

Sistema respiratório

DPOC e asma dominam o eixo — e a pegadinha do oxigênio no DPOC é campeã.

2 · DPOC e asma

DOENÇA	CARACTERÍSTICA
DPOC	Limitação crônica e pouco reversível ao fluxo aéreo. Principal fator: tabagismo. Tosse crônica, expectoração, dispneia progressiva, tórax em barril.
Asma	Inflamação crônica com obstrução reversível e hiper-responsividade brônquica. Crises com sibilos, tosse, dispneia e aperto no peito. Gatilhos: alérgenos, exercício, frio.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A pegadinha do oxigênio no DPOC tem base fisiológica: o paciente com DPOC avançado retém CO_2 cronicamente, e seu estímulo respiratório passa a depender mais da **hipoxemia** do que do CO_2 . Ofertar O_2 em excesso pode reduzir esse estímulo e agravar a retenção — daí a indicação de **máscara de Venturi**, que entrega FiO_2 exata e titulável. Atenção: isso *não* significa negar oxigênio a quem está hipoxêmico — significa titular.

BIZU ESTRATÉGICO

Alvo de saturação: no paciente geral, $\text{SatO}_2 \geq 94\%$. No **retentor crônico de CO_2 (DPOC)**, o alvo é mais baixo — em torno de **88–92%**. Enunciado que manda saturar o DPOC em 99% está errado.

PEGADINHA CLÁSSICA

Na crise de asma, o **silêncio auscultatório** não é melhora — é **gravidade extrema**: significa que o fluxo aéreo está tão reduzido que nem sibilo se produz. A banca oferece “sibilos desapareceram, paciente melhorou” como alternativa. É erro grave.

◆ Insuficiência respiratória

TIPO	GASOMETRIA E CAUSA
Tipo I (hipoxêmica)	PaO ₂ baixa com CO ₂ normal ou baixo. Falha de troca. Ex.: pneumonia, SDRA, edema pulmonar.
Tipo II (hipercápica)	PaO ₂ baixa com CO ₂ elevado. Falha de ventilação (bomba). Ex.: DPOC descompensado, depressão do SNC, doença neuromuscular.

BIZU ESTRATÉGICO

Sinais de esforço respiratório que caem no enunciado: **tiragem intercostal, batimento de asa do nariz, uso de musculatura acessória, cianose e agitação**. A agitação e a confusão são sinais precoces de hipóxia — a sonolência já é tardia (hipercapnia).

3

Sistema nervoso

AVC é tempo. Glasgow é número. Os dois caem em toda prova.

3 · Acidente vascular cerebral

O AVC divide-se em **isquêmico** (cerca de 85% dos casos, por oclusão) e **hemorrágico** (por rotura vascular). A distinção é feita por **tomografia** — e é obrigatória antes de qualquer trombólise.

Protocolo de trombólise no AVC isquêmico agudo · Ministério da Saúde/CONITEC

ITEM	PARÂMETRO
Janela terapêutica	Trombólise em até 4,5 horas do início dos sintomas.
Exame obrigatório	TC de crânio sem contraste, sem sinais de hemorragia.
Trombolítico	Alteplase 0,9 mg/kg — 10% em bolus, 90% em infusão de 1 hora.
Escala	NIHSS, para quantificar o déficit e acompanhar a evolução.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o horário do início dos sintomas é a informação mais importante da anamnese: a janela de 4,5 h conta do **início dos sintomas**, não da chegada ao hospital. Quando o paciente acorda com o déficit (*wake-up stroke*), considera-se o último momento em que foi visto bem. É por isso que a enfermagem pergunta, insistentemente, “**que horas você estava bem pela última vez?**”

BIZU ESTRATÉGICO

Reconhecimento rápido — mnemônico **SAMU/FAST**: Face (desvio de rima), Arm (queda do braço), Speech (fala alterada), Time (hora de ligar). Na prova, “desvio de rima + fraqueza súbita de um lado + fala arrastada” = AVC até prova em contrário.

PEGADINHA CLÁSSICA

Nunca administrar trombolítico **antes da TC**: se o AVC for hemorrágico, o trombolítico é catastrófico. Outra: no AVC isquêmico agudo, **não se baixa a PA agressivamente** — a hipertensão é parcialmente compensatória para perfundir a penumbra. Controla-se apenas acima dos limites do protocolo.

3 · Escala de Coma de Glasgow

Avalia o nível de consciência por três parâmetros. A pontuação varia de **3 (pior) a 15 (melhor)**.

PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Abertura ocular	1 a 4 pontos (4 = espontânea; 1 = ausente).
Resposta verbal	1 a 5 pontos (5 = orientado; 1 = ausente).
Resposta motora	1 a 6 pontos (6 = obedece a comandos; 1 = ausente).

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde os cortes: **3 é o mínimo** (não existe zero!) e **15 o máximo**. Glasgow ≤ 8 indica coma e é o gatilho clássico para **considerar via aérea definitiva** (intubação) — “Glasgow 8, intuba”.

PEGADINHA CLÁSSICA

O erro campeão: dizer que a escala vai de **0 a 15**. Não vai — o mínimo é **3**, porque cada um dos três parâmetros vale no mínimo 1 ponto, mesmo sem resposta alguma.

◆ Hipertensão intracraniana

BIZU ESTRATÉGICO

A tríade de Cushing (resposta à PIC elevada) é: **hipertensão arterial com alargamento da pressão de pulso, bradicardia e alteração do padrão respiratório**. Note o contraintuitivo: é *bradicardia*, não taquicardia — e é aí que a banca pega. Cuidados: cabeceira a 30°, cabeça alinhada, evitar manobras que aumentem a PIC.

4

Sistema urinário

Doença renal crônica, diálise e ITU. Os números da função renal caem sempre.

4 · Doença renal crônica

A DRC é a perda progressiva e irreversível da função renal, classificada pela **taxa de filtração glomerular (TFG)**. As duas principais causas no Brasil são **hipertensão e diabetes** — o que conecta este eixo aos anteriores.

ESTÁGIO	TFG (ML/MIN/1,73M ²)
Estágio 1	TFG ≥ 90, com lesão renal (proteinúria, alteração de imagem).
Estágio 2	TFG 60–89, com lesão renal.
Estágio 3	TFG 30–59. Redução moderada.
Estágio 4	TFG 15–29. Redução grave; preparo para terapia substitutiva.
Estágio 5	TFG < 15. Falência renal; indicação de diálise ou transplante.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que HAS e diabetes destroem o rim: ambos lesam o **glomérulo** — a hipertensão pela pressão mecânica sobre os capilares, o diabetes pela glicotoxicidade que espessa a membrana basal. Daí a proteinúria ser sinal precoce: a barreira glomerular, danificada, deixa passar proteína que deveria reter.

◆ Cuidados na hemodiálise

BIZU ESTRATÉGICO

Regra de ouro da fístula arteriovenosa (FAV): no braço da fístula **NÃO se afere PA, NÃO se punciona veia, NÃO se coleta sangue**. Avalia-se diariamente **frêmito** (vibração à palpação) e **sopro** (à ausculta) — se sumiram, suspeita-se de trombose e comunica-se imediatamente.

PEGADINHA CLÁSSICA

Pesagem antes e depois da sessão é obrigatória — o **ganho de peso interdialítico** estima o volume a ultrafiltrar. E cuidado com o enunciado que manda puncionar o braço da FAV “por ser um acesso calibroso”: é erro grave, compromete o acesso vascular do paciente.

◆ Infecção do trato urinário

BIZU ESTRATÉGICO

ITU associada a cateter é das IRAS mais comuns. Prevenção que cai: indicação criteriosa, **sistema de drenagem fechado**, coletor **sempre abaixo do nível da bexiga** e **retirada precoce** — o melhor cateter é o que já foi removido. Trocar a sonda “de rotina” não previne infecção.

5

Sistema digestório

Hemorragia digestiva, cirrose e pancreatite. Reconhecer o sangramento pela cor é o bizu.

5 · Hemorragia digestiva

CLASSIFICAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
Alta (HDA)	Acima do ângulo de Treitz. Manifesta-se por hematêmese (vômito com sangue, às vezes em borra de café) e melena (fezes escuras, pastosas, fétidas).
Baixa (HDB)	Abaixo do ângulo de Treitz. Manifesta-se por enterorragia/hematoquezia (sangue vivo nas fezes).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a melena é **preta**: o sangue que percorre todo o trato digestório sofre ação do ácido gástrico e das bactérias, degradando a hemoglobina — o que escurece as fezes e dá o odor característico. Já o sangue vivo indica origem *baixa* ou trânsito muito rápido. A cor conta de onde veio.

BIZU ESTRATÉGICO

Enunciado com hematêmese em borra de café + melena = hemorragia alta. Com sangue vivo pelo reto = baixa. Prioridade sempre: estabilidade hemodinâmica (acesso calibroso, volume) antes de investigar a causa.

◆ Cirrose e suas complicações

COMPLICAÇÃO	CARACTERÍSTICA
Ascite	Acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Controle de peso e circunferência abdominal.
Varizes esofágicas	Consequência da hipertensão portal. Risco de sangramento maciço.
Encefalopatia hepática	Acúmulo de amônia. Confusão, flapping (asterix), sonolência.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica da **encefalopatia hepática**: o fígado doente não converte amônia em ureia, e a amônia atinge o SNC. Por isso a conduta inclui **lactulose** (que acidifica o cólon e aprisiona a amônia) e a restrição proteica *criteriosa*. O **flapping** é o sinal que a prova adora citar.

 Pancreatite aguda**BIZU ESTRATÉGICO**

Dor em **faixa**, epigástrica, com irradiação para o dorso, que melhora ao inclinar-se para frente. Enzimas: **amilase e lipase** elevadas (a lipase é mais específica). Conduta inicial: **jejum** (repouso pancreático), hidratação vigorosa e analgesia.

6

Sistema músculo-esquelético

Fraturas e as complicações da imobilidade — onde a enfermagem faz toda a diferença.

6 · Fraturas e imobilidade

TIPO/ITEM	CARACTERÍSTICA
Fratura fechada	Sem comunicação com o meio externo.
Fratura exposta (aberta)	Com solução de continuidade da pele. Risco elevado de infecção e osteomielite.
Sinais clássicos	Dor, edema, deformidade, crepitação, impotência funcional, encurtamento.

BIZU ESTRATÉGICO

Avaliação neurovascular do membro — mnemônico dos **5 P**: **P**ain (dor), **P**allor (palidez), **P**ulse (ausência de pulso), **P**aresthesia (parestesia), **P**aralysis (paralisia). São os sinais da **síndrome compartimental** — emergência que exige comunicação imediata.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a dor da síndrome compartimental é **desproporcional** e não cede a analgésico: a pressão dentro do compartimento fascial colapsa a microcirculação e causa isquemia muscular. O pulso pode estar *presente* nas fases iniciais — esperar o pulso sumir para agir é tarde demais. Dor desproporcional + parestesia já é sinal de alerta.

PEGADINHA CLÁSSICA

Em fratura exposta, **não se recoloca o osso para dentro** e não se lava a ferida abundantemente no atendimento inicial: cobre-se com curativo estéril, imobiliza-se **como encontrado** e encaminha-se. A banca oferece “reduzir a fratura no local” como alternativa.

◆ Complicações da imobilidade

O QUE A IMOBILIDADE CAUSA — E A ENFERMAGEM PREVINE

- ◆ **Lesão por pressão** — mudança de decúbito, superfícies de suporte, avaliação da pele.
- ◆ **Trombose venosa profunda** — mobilização precoce, meias/compressão, profilaxia.
- ◆ **Pneumonia** — exercícios respiratórios, cabeceira elevada.
- ◆ **Constipação e perda de massa muscular** — hidratação, dieta, exercícios passivos.

7

Sistema endócrino

Diabetes é o rei deste eixo. Os números do diagnóstico caem literalmente.

7 · Diabetes mellitus

O diagnóstico do DM é feito pela identificação de hiperglicemia, por qualquer um dos critérios abaixo. Considera-se jejum a ausência de ingestão calórica por ≥ 8 horas.

Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes — edição 2025

EXAME	CRITÉRIO DIAGNÓSTICO
Glicemia de jejum	≥ 126 mg/dL.
Hemoglobina glicada (HbA1c)	$\geq 6,5\%$.
TTGO 2 horas	≥ 200 mg/dL (após 75 g de glicose).
Glicemia ao acaso	≥ 200 mg/dL na presença de sintomas típicos.

REFERÊNCIA	VALOR
Glicemia de jejum normal	70–99 mg/dL.
Glicemia de jejum alterada (pré-diabetes)	100–125 mg/dL.
HbA1c normal	$< 5,7\%$. Pré-diabetes: 5,7–6,4%.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O que a **HbA1c** mede e por que ela é diferente da glicemia: a hemoglobina glicada reflete a média glicêmica dos **últimos 2 a 3 meses** (a meia-vida da hemácia), enquanto a glicemia é um retrato do momento. Por isso ela avalia *controle*, não flagra o pico de ontem. E por isso anemias e hemoglobinopatias distorcem seu resultado — alteram o ciclo de vida da hemácia.

BIZU ESTRATÉGICO

Decore os quatro números do diagnóstico: **126** (jejum) · **6,5%** (HbA1c) · **200** (TTGO 2h) · **200** ao acaso com sintomas. Os sintomas clássicos são os **4 P**: *poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso*.

COMO A BANCA COBRA

"Paciente assintomático apresenta glicemia de jejum de 118 mg/dL. Esse resultado caracteriza..."

Glicemia de jejum alterada — **pré-diabetes** (100–125). Não é diabetes, porque o corte é 126. A banca escolhe valores *na fronteira* justamente para testar se você sabe o número exato.

◆ Metas de controle glicêmico

PARÂMETRO	META
HbA1c	< 7% para a maioria dos adultos. Individualizar: mais rígida no jovem sem comorbidade, mais flexível no idoso frágil.
Glicemia capilar em jejum / pré-prandial	80–130 mg/dL.
Glicemia 2 h após o início da refeição	< 180 mg/dL.
Tempo no alvo (TIR)	> 70% do tempo entre 70–180 mg/dL (monitorização contínua).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O **TIR (Time in Range / Tempo no Alvo)** é o parâmetro que vem ganhando espaço e já aparece em prova. Ele responde ao que a HbA1c não mostra: *a variabilidade*. Dois pacientes podem ter a mesma HbA1c de 7% — um estável, outro oscilando entre hipoglicemias e picos. A média é igual; o risco, não. Por isso a meta é passar **mais de 70% do tempo entre 70 e 180 mg/dL**.

◆ Tratamento do DM2 — a mudança de 2025

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Até recentemente, a resposta automática era: **metformina para todos** em primeira linha, salvo contraindicação. A atualização da SBD **retirou essa exclusividade**. Hoje a escolha inicial é individualizada por três pilares, nesta ordem: **risco cardiovascular → IMC → HbA1c**.

Na prática: paciente com doença cardiovascular ou renal se beneficia de **iSGLT2** ou **agonista de GLP-1**; com obesidade, das drogas que também reduzem peso (GLP-1, tirzepatida); com HbA1c muito elevada (≥ 9 –10%) ou sintomas de insulinopenia, pode-se **começar já com insulina**.

PEGADINHA CLÁSSICA

Marcar “metformina é sempre a primeira escolha para todo DM2” virou **armadilha**. Ela continua sendo uma opção importante e muito usada — mas *não é mais universal e automática*. Atenção ao ano da diretriz citada no enunciado: provas antigas ainda cobram a metformina obrigatória.

◆ Insulinas no SUS — atualização importante

Portaria SECTICS/MS nº 59, de 28 de novembro de 2024 · CONITEC

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O SUS sempre ofertou as **insulinas humanas NPH e regular**. As **análogas** eram restritas ao **DM1**. Em novembro de 2024, a CONITEC incorporou as **análogas de ação rápida e prolongada também para o DM2**.

O motivo não foi superioridade clínica — a própria CONITEC apontou que as análogas são *semelhantes* às humanas em eficácia. Foi **garantia de abastecimento**: há restrição global de insulina humana, e o principal fornecedor anunciou a descontinuação de sua produção. A incorporação foi condicionada a preço competitivo e inserção gradual na rede.

O QUE O SUS OFERTA HOJE

- ◆ **Insulinas humanas**: NPH (intermediária) e regular (rápida) — a base histórica do sistema.
- ◆ **Análogos de ação rápida e prolongada**: agora também para o **DM2**, não só DM1.
- ◆ **Glargina** — disponibilizada pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- ◆ **Glargina e degludeca** — no Componente Especializado (CEAF), Grupo 1A, de aquisição pela União.
- ◆ O paciente também tem direito às **agulhas** para aplicação.

BIZU ESTRATÉGICO

Se o enunciado disser que “o SUS oferta apenas insulinas humanas NPH e regular”, está **desatualizado**. E se disser que as análogas são “comprovadamente superiores”, também está errado — a incorporação se deu por **segurança de abastecimento**, não por superioridade demonstrada.

7 · Emergências glicêmicas

QUADRO	CARACTERÍSTICA
Hipoglicemia	Glicemia < 70 mg/dL. Sudorese fria, tremor, taquicardia, fome, confusão, convulsão, coma. Instalação rápida.
Cetoacidose diabética (CAD)	Hiperglicemia + cetose + acidose. Mais típica do DM1. Hálito cetônico, respiração de Kussmaul, desidratação, dor abdominal.
Estado hiperglicêmico hiperosmolar	Hiperglicemia muito elevada, sem cetose significativa. Mais típico do DM2 e do idoso. Desidratação profunda e alteração de consciência.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a CAD dá **respiração de Kussmaul**: sem insulina, o organismo queima gordura e produz corpos cetônicos — ácidos. Instala-se acidose metabólica, e o pulmão tenta compensar eliminando CO₂ com respirações amplas e profundas. O **hálito cetônico** (de maçã) vem da acetona exalada. Cada sinal é consequência direta da via metabólica.

BIZU ESTRATÉGICO

Diante de rebaixamento de consciência em diabético, **faça glicemia capilar primeiro**. Na dúvida entre hipo e hiper, trata-se a **hipoglicemia** — ela mata mais rápido. Consciente: carboidrato via oral. Inconsciente: **nada por via oral** (risco de broncoaspiração) — glicose EV.

PEGADINHA CLÁSSICA

Erro grave e cobrado: **oferecer líquido açucarado a paciente inconsciente**. Nunca. E outra: no tratamento da CAD, a prioridade inicial é **hidratação** — a insulina vem em seguida, com atenção ao potássio, que despenca quando a insulina age.

◆ Tireoide

DISTÚRBIO	MANIFESTAÇÕES
Hipotireoidismo	Metabolismo lento: fadiga, ganho de peso, intolerância ao frio, bradicardia, pele seca, constipação, sonolência.
Hipertireoidismo	Metabolismo acelerado: perda de peso, intolerância ao calor, taquicardia, tremor, insônia, diarreia, exoftalmia (Graves).

BIZU ESTRATÉGICO

Pense em **acelerador** e **freio**: hiper = tudo acelerado (taqui, magro, calor, agitado); hipo = tudo lento (bradi, ganha peso, frio, sonolento). Deduzir pelo metabolismo dispensa decorar as duas listas.



Síntese

Os números e as trocas que decidem a questão.

8 · Revisão rápida do eixo

CARDIOVASCULAR E RESPIRATÓRIO

- ◆ HAS (diretriz 2025): **120/80 já é pré-hipertensão**; PA normal é só < 120/80.
- ◆ Diagnóstico continua **≥ 140/90** no consultório (≥ 130/80 na MRPA). Meta do tratado: **< 130/80**.
- ◆ IAM: **ECG em até 10 minutos**; marcador de escolha é a **troponina**.
- ◆ IC esquerda = congestão pulmonar; IC direita = congestão sistêmica.
- ◆ DPOC: alvo de SatO₂ **88–92%**; Venturi para FiO₂ precisa.
- ◆ Asma: **silêncio auscultatório = gravidade**, não melhora.

NERVOSO, URINÁRIO E ENDÓCRINO

- ◆ AVC: janela de **4,5 h**; TC **antes** do trombolítico; alteplase 0,9 mg/kg.
- ◆ Glasgow: **3 a 15** (não existe zero); ≤ 8 = coma, considerar via aérea definitiva.
- ◆ Cushing (PIC alta): hipertensão + **bradicardia** + alteração respiratória.
- ◆ FAV: **não** aferir PA, puncionar ou coletar no braço; avaliar frêmito e sopro.
- ◆ DM: **126 · 6,5% · 200 · 200**. Pré-diabetes: 100–125.
- ◆ Metas: HbA1c < 7%; jejum 80–130; pós-prandial < 180; **TIR > 70%** (70–180).
- ◆ DM2 (2025): metformina **não é mais** primeira linha universal — individualiza por RCV, IMC e HbA1c.
- ◆ SUS: análogos de ação rápida e prolongada agora também para **DM2** (Portaria 59/2024).
- ◆ Hipoglicemia < 70; inconsciente = **nada por via oral**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) Glasgow de 0 a 15; (2) saturar o DPOC em 99%; (3) silêncio auscultatório como melhora; (4) trombolítico antes da TC; (5) puncionar o braço da fístula; (6) açúcar oral em paciente inconsciente; (7) dizer que a diretriz de 2025 diagnostica hipertensão a partir de 130/80 — não: 120/80 *rotula* como pré-hipertensão, 140/90 *diagnostica*, 130/80 é a *meta*. Dominar essas sete blinda boa parte da clínica.

“Em clínica, a prova não pergunta o que você sabe. Pergunta o que você faria — e em quanto tempo.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · ASSISTÊNCIA POR SISTEMAS

Parâmetros conferidos nas diretrizes vigentes: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (SBC/SBH/SBN), Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025 e protocolos do Ministério da Saúde/CONITEC. Diretrizes são revisadas periodicamente — confirme os valores da versão do ano antes da prova.